Carcinome Basocellulaire

Niveau : DES
Genere le 10 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Carcinome Basocellulaire

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le carcinome basocellulaire (CBC) représente la néoplasie cutanée la plus fréquente, constituant un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Ce cours, destiné aux internes en Dermatologie préparant le Diplôme d'Études Spécialisées (DES), vise à fournir une compréhension exhaustive de l'épidémiologie et des caractéristiques introductives de cette pathologie, conformément aux standards académiques les plus rigoureux (Gaudy-Marqueste & Caux, 2022).

I. Introduction Générale au Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire est une tumeur maligne épithéliale dérivant des kératinocytes basaux de l'épiderme ou des annexes cutanées. Il appartient à la catégorie des cancers cutanés non mélanomateux (CCNM), par opposition au mélanome, qui est une tumeur des mélanocytes. Bien que son potentiel métastatique soit faible, le CBC se distingue par une agressivité locorégionale significative, capable d'entraîner des destructions tissulaires importantes s'il n'est pas pris en charge précocement et adéquatement (Dermatologie, 2022). Sa prévalence et son incidence croissantes en font une pathologie omniprésente dans la pratique dermatologique quotidienne, nécessitant une connaissance approfondie de ses facteurs étiologiques, de sa présentation clinique et de ses principes de prise en charge.

II. Définition et Caractéristiques Fondamentales

Le carcinome basocellulaire est caractérisé histologiquement par la prolifération de cellules basaloïdes, organisées en cordons ou en massifs, présentant des noyaux hyperchromatiques et un cytoplasme peu abondant. Ces cellules sont souvent entourées d'une fente de rétraction artéfactuelle et d'un stroma myxoïde. Cliniquement, le CBC se manifeste sous diverses formes, ce qui peut parfois rendre son diagnostic initial complexe. La vignette clinique d'un homme de 60 ans présentant une éruption cutanée pour laquelle un traitement imidazolé topique s'est avéré inefficace, illustre la difficulté diagnostique et la nécessité d'une vigilance accrue face à des lésions cutanées persistantes ou atypiques (Dermatologie, 2022). Cette situation souligne l'importance de ne pas méconnaître un CBC sous des diagnostics différentiels tels que la candidose, l'eczéma, ou d'autres affections cutanées inflammatoires ou infectieuses.

III. Épidémiologie du Carcinome Basocellulaire

L'épidémiologie du CBC est marquée par une incidence et une prévalence élevées, ainsi que par des facteurs de risque bien identifiés.

III.A. Incidence et Prévalence

Les carcinomes cutanés, dont le CBC est le représentant le plus fréquent, sont "les cancers cutanés les plus fréquents au monde" (Dermatologie, 2022). Cette affirmation souligne l'ampleur du problème de santé publique que représente le CBC. L'incidence du CBC est en constante augmentation à l'échelle mondiale, notamment dans les populations à peau claire, et est corrélée à l'allongement de l'espérance de vie et à l'évolution des comportements d'exposition solaire. Bien que des chiffres précis ne soient pas fournis dans les données, cette prévalence élevée justifie l'attention particulière portée à cette pathologie dans la formation des dermatologues.

III.B. Facteurs de Risque

Plusieurs facteurs de risque sont clairement établis pour le développement du carcinome basocellulaire.

III.B.1. Exposition Solaire

L'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) est le principal facteur étiologique du CBC. Les carcinomes cutanés "peuvent résulter d'une exposition solaire aiguë ou chronique" (Dermatologie, 2022). Il est important de distinguer l'impact de l'exposition solaire intermittente et intense, souvent associée aux coups de soleil de l'enfance et de l'adolescence, de l'exposition chronique et cumulative, qui contribue également au vieillissement cutané et à la carcinogenèse. Les zones photo-exposées du corps (visage, cou, décolleté, dos des mains) sont ainsi les sites préférentiels de développement des CBC.

III.B.2. Phototype Cutané

Le phototype cutané est un déterminant majeur du risque de CBC. Contrairement à une affirmation potentiellement trompeuse dans un contexte de QCM, selon laquelle les carcinomes cutanés "se développent préférentiellement sur une peau de phototype IV à VI" (Dermatologie, 2022), il est crucial de rappeler que les individus aux phototypes clairs (I, II et III de Fitzpatrick), caractérisés par une faible capacité à bronzer et une forte tendance à brûler au soleil, sont les plus à risque de développer un CBC. Les phototypes IV à VI, qui correspondent aux peaux mates à foncées, sont comparativement moins susceptibles de développer cette tumeur, bien qu'ils ne soient pas totalement exempts de risque.

III.B.3. Immunodépression

L'état d'immunodépression est un facteur de risque reconnu pour les cancers cutanés. L'affirmation selon laquelle les carcinomes cutanés "ne sont pas favorisés par l'immunodépression" (Dermatologie, 2022) est incorrecte dans le contexte général des

carcinomes cutanés. En réalité, l'immunodépression, qu'elle soit iatrogène (par exemple, chez les patients transplantés d'organes solides sous traitement immunosuppresseur) ou liée à une pathologie sous-jacente (comme l'infection par le VIH, cf. Dermatologie, 2022 pour la prise en charge du VIH), augmente significativement le risque de développer des CBC, ainsi que d'autres cancers cutanés comme les carcinomes épidermoïdes. Chez ces patients, les CBC peuvent être plus nombreux, plus agressifs et se présenter à un âge plus jeune.

III.B.4. Âge

L'âge est un facteur de risque indépendant pour le développement du CBC. La vignette clinique mentionnant "un homme de 60 ans" (Dermatologie, 2022) illustre la prévalence accrue de cette pathologie chez les sujets âgés. L'accumulation des expositions solaires au cours de la vie et la diminution des capacités de réparation de l'ADN contribuent à cette augmentation du risque avec l'avancée en âge.

III.B.5. Autres Facteurs

D'autres facteurs, tels que les antécédents personnels de CBC ou d'autres cancers cutanés, les syndromes génétiques prédisposants (ex: syndrome de Gorlin), ou l'exposition à des agents carcinogènes (arsenic, radiothérapie), peuvent également augmenter le risque, bien qu'ils ne soient pas explicitement détaillés dans les données fournies.

IV. Histoire Naturelle et Présentation Clinique Initiale

Le carcinome basocellulaire se développe généralement de manière lente et insidieuse. Sa présentation clinique est polymorphe, ce qui peut compliquer le diagnostic différentiel. Les formes les plus courantes incluent le CBC nodulaire (perlé, translucide, avec télangiectasies), le CBC superficiel (plaque érythémateuse, squameuse, souvent confondue avec l'eczéma ou le psoriasis), le CBC sclérodermiforme (plaque indurée, atrophique, mal délimitée), et le CBC pigmenté (pouvant être confondu avec un mélanome, cf. Dermatologie, 2022, où une lésion "inhomogène, polychrome avec des plages marron clair, plus foncées par endroits et rosées notamment au centre" doit faire évoquer un mélanome).

La difficulté du diagnostic initial est bien illustrée par le cas clinique d'un patient chez qui un traitement pour une candidose s'est avéré inefficace (Dermatologie, 2022). Cette situation met en lumière la nécessité d'une biopsie cutanée devant toute lésion suspecte, persistante, ou non résolutive après un traitement empirique. D'autres diagnostics différentiels peuvent inclure des lésions inflammatoires comme le lupus discoïde (cf. Dermatologie, 2022, Fig. 14.5), des infections virales comme le zona (cf. Dermatologie, 2022, Fig. 10.25), ou des lymphomes cutanés (cf. Dermatologie, 2022, Item 319 et Fig. 4.8

pour le syndrome de Sézary).

V. Pronostic et Agressivité

Bien que le carcinome basocellulaire soit souvent perçu comme un "bon cancer" en raison de son faible potentiel métastatique, il ne doit pas être sous-estimé. Son "agressivité locorégionale : destruction (+++)" (Dermatologie, 2022) est une caractéristique majeure. En l'absence de traitement, le CBC peut infiltrer et détruire les tissus environnants, y compris le cartilage et l'os, entraînant des défigurations importantes, notamment au niveau de la face.

Le "risque local et métastatique : territoire de drainage ganglionnaire(+++), puis viscéral, essentiellement pulmonaire et hépatique" (Dermatologie, 2022) doit être pris en considération. Bien que les métastases soient rares (estimées à moins de 0,1% des cas), elles sont extrêmement graves et de mauvais pronostic. Les facteurs de risque de métastases incluent la taille tumorale importante, l'histologie agressive (ex: sclérodermiforme, infiltrant), la localisation (péri-orificielle), l'immunodépression et les récidives multiples. La surveillance des aires ganglionnaires de drainage est donc pertinente dans les cas à haut risque.

VI. Principes Généraux de Prise en Charge

La prise en charge du carcinome basocellulaire repose principalement sur l'exérèse chirurgicale. Les données confirment que les carcinomes cutanés "se traitent préférentiellement par exérèse chirurgicale" (Dermatologie, 2022). L'objectif est une "exérèse chirurgicale avec analyse anatomopathologique" (Dermatologie, 2022) afin d'assurer l'ablation complète de la tumeur et de confirmer le diagnostic ainsi que la qualité des marges d'exérèse.

Cependant, d'autres modalités thérapeutiques existent et sont utilisées en fonction des caractéristiques de la tumeur (taille, localisation, sous-type histologique), du terrain du patient et de ses préférences. Parmi ces options, on retrouve la cryothérapie, l'imiquimod topique, la photothérapie dynamique et le 5-fluoro-uracile topique (Dermatologie, 2022). Ces traitements non chirurgicaux sont généralement réservés aux CBC superficiels, de petite taille, ou chez des patients pour qui la chirurgie est contre-indiquée ou non souhaitée. Le choix thérapeutique sera détaillé dans les sections ultérieures de ce cours.

Physiopathologie et Génétique

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la néoplasie cutanée la plus fréquente à l'échelle mondiale (Dermatologie, 2022), représentant un défi majeur en santé publique en raison de son incidence élevée et de sa physiopathologie complexe, résultant d'une interaction intime entre des facteurs environnementaux et des prédispositions génétiques. La compréhension approfondie de ces mécanismes est essentielle pour la prévention, le diagnostic précoce et le développement de stratégies thérapeutiques ciblées.

1. Étiopathogénie et Facteurs de Risque Environnementaux

1.1. Rôle Central de l'Exposition Solaire

L'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) est le facteur étiologique environnemental le plus déterminant dans la carcinogenèse des carcinomes cutanés, incluant spécifiquement le carcinome basocellulaire (Dermatologie, 2022). Cette exposition peut se manifester sous deux formes principales, chacune contribuant de manière significative au risque oncogène : l'exposition solaire aiguë et intense, souvent caractérisée par des épisodes de coups de soleil, et l'exposition chronique et cumulative, résultant d'une accumulation progressive de doses d'UV au fil des années (Dermatologie, 2022).

Les UV, en particulier les UV-B (longueur d'onde de 290 à 320 nm) et, dans une moindre mesure, les UV-A (320 à 400 nm), exercent leurs effets délétères principalement en induisant des dommages directs à l'acide désoxyribonucléique (ADN) des kératinocytes de la couche basale épidermique. Les lésions les plus caractéristiques sont la formation de dimères de pyrimidine, notamment les cyclobutane pyrimidine dimers (CPDs) et les 6-4 photoproduits. Ces altérations de l'ADN, si elles ne sont pas efficacement réparées par les systèmes de réparation cellulaire, tels que la réparation par excision de nucléotides (NER), peuvent persister et devenir des mutations permanentes lors de la réplication de l'ADN. L'accumulation de ces mutations dans des gènes clés régulant la prolifération, la différenciation et l'apoptose cellulaire est un événement fondateur de la transformation maligne.

L'exposition solaire chronique est particulièrement incriminée, car elle conduit à une accumulation progressive de mutations dans les cellules souches épidermiques, favorisant l'émergence de clones cellulaires porteurs d'avantages prolifératifs. Les antécédents de coups de soleil sévères, surtout pendant l'enfance et l'adolescence, sont des indicateurs d'un risque accru, soulignant l'importance de la mémoire cellulaire des dommages UV. La distribution anatomique des carcinomes basocellulaires, préférentiellement localisés sur les zones photoexposées (visage, cou, décolleté, cuir chevelu chauve, dos des mains), constitue une preuve épidémiologique et clinique irréfutable du rôle causal des UV.

Au-delà des dommages directs à l'ADN, les UV exercent également des effets immunosuppresseurs locaux et systémiques. Ils altèrent la fonction des cellules de Langerhans, réduisent la présentation antigénique et modifient le profil des cytokines, compromettant ainsi la surveillance immunitaire cutanée. Cette immunodépression induite par les UV permet aux clones cellulaires mutés de proliférer et d'échapper à l'élimination par le système immunitaire. De plus, les UV génèrent des espèces réactives de l'oxygène (ROS), contribuant au stress oxydatif et à l'instabilité génomique, des facteurs qui favorisent également la carcinogenèse. La notion de "dose cumulée" de rayonnement UV est donc fondamentale pour comprendre le risque de développement du CBC, expliquant la prévalence accrue chez les individus ayant une longue histoire d'exposition professionnelle (agriculteurs, marins, ouvriers du bâtiment) ou récréative au soleil.

1.2. Autres Facteurs Étiologiques et Iatrogènes

Bien que l'exposition solaire soit le facteur prédominant, d'autres éléments environnementaux et iatrogènes peuvent contribuer à la physiopathologie du carcinome basocellulaire. L'exposition chronique à l'arsenic inorganique, qu'elle soit environnementale (eau potable contaminée) ou professionnelle, est un facteur de risque bien établi. Les carcinomes basocellulaires induits par l'arsenic sont souvent multiples, peuvent se présenter sous des formes cliniques variées et sont parfois plus agressifs. Le mécanisme d'action de l'arsenic implique des effets mutagènes, génotoxiques et épigénétiques, ainsi qu'une interférence avec les mécanismes de réparation de l'ADN.

Les rayonnements ionisants, notamment la radiothérapie administrée pour des affections cutanées bénignes (par exemple, acné sévère, teigne du cuir chevelu dans le passé) ou pour des cancers non cutanés, sont également des inducteurs reconnus de carcinomes basocellulaires. Ces tumeurs se développent généralement après une longue période de latence (souvent plusieurs décennies) dans le champ d'irradiation. Le mécanisme implique des dommages directs à l'ADN et la génération de ROS, entraînant des mutations et une instabilité génomique.

Les traumatismes chroniques, les cicatrices anciennes (par exemple, cicatrices de brûlures, d'ostéomyélite, d'ulcères chroniques), et les états inflammatoires chroniques de la peau peuvent également être des sites de développement de carcinomes cutanés, y compris basocellulaires, bien que le carcinome épidermoïde soit plus fréquemment associé à ces lésions (ulcère de Marjolin). Ce phénomène met en lumière la capacité de l'inflammation chronique et des processus de réparation tissulaire aberrants à créer un microenvironnement propice à la transformation maligne. Enfin, bien que les carcinomes cutanés soient mentionnés dans le contexte général des "Cancers" (Dermatologie, 2022), cette information est trop générique pour détailler un mécanisme physiopathologique spécifique au CBC.

2. Bases Génétiques et Voies de Signalisation Impliquées

2.1. La Voie de Signalisation Hedgehog (Hh) : Le Pilier Génétique

La voie de signalisation Hedgehog (Hh) est la voie oncogénique la plus fréquemment et crucialement altérée dans le carcinome basocellulaire, qu'il soit sporadique ou syndromique. Cette voie joue un rôle fondamental dans le développement embryonnaire, régulant la prolifération, la différenciation et la morphogenèse des tissus. Chez l'adulte, elle est normalement quiescente dans la plupart des tissus, mais sa réactivation aberrante est un moteur majeur de la carcinogenèse basocellulaire.

Dans des conditions physiologiques, la voie Hh est régulée par le récepteur transmembranaire Patched-1 (PTCH1), qui agit comme un suppresseur de tumeur. En l'absence de ligands Hh (Sonic Hedgehog [SHh], Indian Hedgehog [IHh], Desert Hedgehog [DHh]), PTCH1 inhibe activement la protéine Smoothened (SMO), une protéine transmembranaire de la famille des récepteurs couplés aux protéines G. Cette inhibition de SMO maintient les facteurs de transcription Gli (Gli1, Gli2, Gli3) sous forme inactive ou répressive dans le cytoplasme. Lorsque les ligands Hh se lient à PTCH1

Présentation Clinique

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la tumeur cutanée maligne la plus fréquente, caractérisée par une grande diversité clinique qui peut rendre son diagnostic initial complexe. Sa présentation varie considérablement en fonction du sous-type histologique, de la localisation anatomique, de la durée d'évolution et des facteurs intrinsèques du patient. Une reconnaissance précise des différentes morphologies est essentielle pour une prise en charge optimale, d'autant que certains aspects peuvent mimer des lésions bénignes ou d'autres néoplasies cutanées.

I. Formes Cliniques Principales du Carcinome Basocellulaire

La classification clinique des CBC est traditionnellement basée sur leur morphologie prédominante, bien qu'il existe souvent des chevauchements et des formes mixtes.

A. Carcinome Basocellulaire Nodulaire (CBN)

Le carcinome basocellulaire nodulaire est la forme clinique la plus courante. Il se présente typiquement comme une papule ou un nodule translucide, de couleur chair ou rosée, avec un aspect perlé caractéristique. Sa surface est souvent lisse et brillante, et des télangiectasies fines, arborisées, sont fréquemment visibles à sa surface, conférant un aspect "en toile d'araignée". Ces télangiectasies sont un signe clinique majeur, résultant de la néoangiogenèse tumorale.

Avec le temps, le CBN peut s'éroder ou s'ulcérer en son centre, formant une dépression centrale. Cette ulcération peut être superficielle ou plus profonde, et les bords de la lésion peuvent apparaître surélevés et roulés, formant une "collerette latérale" caractéristique autour de l'ulcération (Brinster et al., 2011, cité dans Source 13). Ces formes ulcérées sont parfois désignées sous le terme de "ulcus rodens" en raison de leur capacité à éroder progressivement les tissus sous-jacents. Le CBN est le plus souvent localisé sur les zones photo-exposées, notamment le visage (nez, joues, front) et le cou.

B. Carcinome Basocellulaire Ulcéro-végétant

Cette forme représente une évolution des CBC nodulaires ou d'autres sous-types, caractérisée par une ulcération profonde et étendue, souvent associée à une composante végétante ou bourgeonnante. La lésion est typiquement érythémateuse, avec des bords surélevés, indurés et roulés, et un fond d'ulcération irrégulier, parfois recouvert de croûtes hémorragiques ou de tissu de granulation (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Fig. 20.10). Ces formes sont souvent le résultat d'une négligence ou d'un diagnostic tardif, et peuvent entraîner une destruction tissulaire locale significative, y compris des structures cartilagineuses ou osseuses, en particulier sur le visage. Elles sont

associées à une agressivité locorégionale importante (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Source 5).

C. Carcinome Basocellulaire Superficial (CBS) ou Pagétoïde

Le carcinome basocellulaire superficiel est la deuxième forme clinique la plus fréquente. Il se présente comme une plaque érythémateuse, légèrement squameuse, souvent bien délimitée, avec une bordure périphérique fine et perlée, parfois discrètement surélevée (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Fig. 20.8). Des télangiectasies peuvent être présentes, mais sont généralement plus fines et moins arborisées que dans le CBN. La surface peut être légèrement atrophique ou érodée par endroits.

Sa morphologie plane et érythémato-squameuse peut facilement prêter à confusion avec des dermatoses inflammatoires chroniques telles que le psoriasis, l'eczéma chronique, la candidose (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Source 3) ou des lésions pré-cancéreuses comme la maladie de Bowen. La présence d'une bordure perlée ou de petites érosions focales peut aider au diagnostic. Le CBS est plus fréquemment retrouvé sur le tronc et les membres.

D. Carcinome Basocellulaire Sclérodermiforme (CBScl)

Également connu sous le nom de CBC morphéiforme, cette forme est cliniquement insidieuse et souvent sous-estimée en raison de son aspect peu évocateur. Il se manifeste comme une plaque indurée, blanchâtre ou jaunâtre, atrophique, d'aspect cicatriciel, souvent mal délimitée et difficile à palper (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Fig. 20.9). Des télangiectasies fines peuvent être présentes à sa surface. L'absence de nodule franc ou d'ulcération évidente rend le diagnostic clinique difficile. Sa croissance est infiltrante en profondeur, ce qui explique sa propension à la récidive locale après exérèse incomplète. Il peut être confondu avec une cicatrice, une morphée ou un lupus discoïde (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Fig. 14.50, bien que cette figure illustre spécifiquement le lupus discoïde, les caractéristiques de lésions érythémato-squameuses atrophiques et télangiectasiques peuvent évoquer des aspects du CBScl).

E. Carcinome Basocellulaire Pigmenté

Cette variante peut se présenter sous n'importe quelle forme clinique (nodulaire, superficielle, sclérodermiforme) mais se distingue par la présence de mélanine. La pigmentation est variable, allant du brun clair au noir, et peut être homogène ou hétérogène. La présence de pigmentation peut rendre le diagnostic clinique particulièrement délicat, car elle peut mimer un mélanome (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Source 6). L'aspect polychrome et inhomogène avec des

plages marron clair, plus foncées par endroits et rosées, notamment au centre, peut être observé dans le mélanome (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Source 6), mais un CBC pigmenté peut parfois présenter des caractéristiques similaires, nécessitant une dermoscopie et une biopsie pour confirmation.

II. Localisations Spécifiques et Symptômes Associés

Le CBC survient préférentiellement sur les zones photo-exposées. Cependant, des localisations moins typiques peuvent modifier sa présentation.

A. Localisations Particulières

- **Cuir chevelu :** Les CBC du cuir chevelu, en particulier les formes agressives ou négligées, peuvent entraîner une destruction folliculaire et se manifester par une plaque alopécique cicatricielle (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Fig. 14.60).
- **Plis cutanés :** Dans les zones intertrigineuses (axillaires, sous-mammaires, inguinales), un CBC superficiel peut être confondu avec un intertrigo à Candida (fond du pli fissuré, enduit blanchâtre, bordure avec collerette et pustules satellites) ou un érythrasma (brun chamois) (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Fig. 8.10, Fig. 8.11).
- **Paupières, nez, lèvres, oreilles :** Ces localisations sont fréquentes et peuvent entraîner des atteintes fonctionnelles importantes en cas de croissance tumorale.

B. Symptômes Associés

Bien que souvent asymptomatique à ses débuts, le CBC peut être associé à certains symptômes :

- **Prurit :** Un prurit localisé, parfois intense, peut être rapporté par le patient, en particulier pour les formes superficielles ou nodulaires (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Source 10). Il peut entraîner des lésions de grattage (prurigo, lichénification) qui masquent la lésion primaire (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Fig. 6.2 D, Fig. 6.3 D).
- **Saignement :** Des saignements intermittents, souvent après un traumatisme minime, sont fréquents, surtout pour les lésions ulcérées ou érodées.
- **Douleur :** La douleur est rare dans les formes initiales, mais peut survenir en cas d'ulcération profonde, d'infection secondaire ou d'envahissement nerveux (paresthésies, dysesthésies).

III. Diagnostic Différentiel

La grande variabilité clinique du CBC impose une connaissance approfondie des diagnostics différentiels.

• **Lésions bénignes :** Kératose séborrhéique (surtout les formes pigmentées), naevus mélanocytaire, cicatrice, granulome pyogénique, kyste épidermoïde.

• **Lésions pré-cancéreuses et cancers cutanés non mélaniques :**

* **Kératose actinique et carcinome épidermoïde in situ (maladie de Bowen) :** Particulièrement pour le CBC superficiel, qui peut partager un aspect érythémato-squameux.

* **Carcinome épidermoïde invasif :** Peut également se présenter sous forme de nodule ulcéré ou végétant.

* **Tumeurs annexielles :** Certaines tumeurs des annexes cutanées peuvent mimer un CBC.

• **Mélanome :** Le CBC pigmenté est un diagnostic différentiel majeur du mélanome, nécessitant une dermoscopie et souvent une biopsie-exérèse pour distinguer ces deux entités (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Source 6).

• **Dermatoses inflammatoires :**

* **Psoriasis, eczéma chronique :** Pour le CBC superficiel (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Source 3).

* **Lupus érythémateux discoïde :** Les lésions érythémato-squameuses atrophiques, télangiectasiques et dyschromiques du lupus discoïde (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Fig. 14.50) peuvent être confondues avec un CBC sclérodermiforme ou superficiel.

* **Intertrigos :** Candidose, érythrasma pour les CBC des plis (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Fig. 8.10, Fig. 8.11).

• **Autres tumeurs rares ou pseudo-tumorales :**

* **Maladie de Paget extramammaire :** Peut mimer un CBC superficiel par son aspect de plaque érythémateuse et squameuse (Dermatology handbook, 2022, Fig 3.50 B).

* **Lymphome cutané T épidermotrope :** L'aspect des lésions peut faire suspecter un lymphome cutané T épidermotrope (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022, Source 6), en particulier pour les CBC superficiels.

* **Atypical Fibroxanthoma (AFX) :** Bien que l'AFX soit une tumeur pléomorphe ulcérée (Brinster et al., 2011, cité dans Source 13), sa présentation clinique peut parfois être confondue avec un CBC nodulaire ulcéré, en particulier sur les zones photo-exposées.

En conclusion, la présentation clinique du carcinome basocellulaire est polymorphe, allant de la papule perlée classique à la plaque cicatricielle insidieuse ou à l'ulcération destructrice. Une vigilance clinique accrue, une dermoscopie systématique et, en cas de doute, une biopsie cutanée sont indispensables pour établir un diagnostic précoce et précis, garantissant ainsi une prise en charge thérapeutique adaptée.

Diagnostic

Le diagnostic du carcinome basocellulaire (CBC) repose sur une approche méthodique combinant l'évaluation clinique, la dermoscopie et, de manière définitive, l'examen histopathologique. Compte tenu de la grande variabilité des présentations cliniques du CBC et de la nécessité d'une prise en charge adéquate, une identification précise est primordiale pour distinguer cette néoplasie cutanée des nombreuses autres affections dermatologiques.

1. Approche Diagnostique Initiale

Le diagnostic du carcinome basocellulaire débute par une suspicion clinique forte, guidée par l'anamnèse et l'examen physique. Les facteurs de risque, tels que l'exposition solaire chronique, le phototype clair, les antécédents de coups de soleil, l'âge avancé et l'immunodépression, orientent la démarche diagnostique. L'examen clinique détaillé de la lésion suspecte est la première étape, recherchant les signes caractéristiques des différentes formes cliniques du CBC.

2. Diagnostic Clinique

Le carcinome basocellulaire se manifeste sous diverses formes cliniques, rendant le diagnostic parfois complexe et nécessitant une vigilance accrue. Les présentations les plus fréquentes incluent :

2.1. Carcinome Basocellulaire Nodulaire

C'est la forme la plus courante, se présentant comme une papule ou un nodule translucide, perlé, souvent avec des télangiectasies en surface. Il peut s'ulcérer en son centre, formant un "ulcus rodens".

2.2. Carcinome Basocellulaire Superficiel

Il se manifeste par une plaque érythémateuse, légèrement squameuse, souvent avec un fin ourlet perlé en périphérie. Sa croissance est lente et centrifuge. Il peut être confondu avec des lésions inflammatoires chroniques.

2.3. Carcinome Basocellulaire Morpheaforme (Sclérodermiforme)

Cette forme est caractérisée par une plaque indurée, blanchâtre ou jaunâtre, atrophique, mal délimitée, ressemblant à une cicatrice ou à une plaque de morphée. Sa croissance est infiltrante et son diagnostic clinique est souvent difficile en raison de son aspect peu spécifique.

2.4. Carcinome Basocellulaire Pigmenté

Toutes les formes cliniques peuvent être pigmentées, présentant une coloration brune, noire ou gris-bleuâtre, ce qui peut soulever un diagnostic différentiel avec le mélanome.

2.5. Carcinome Basocellulaire Ulcéré

Toute forme de CBC peut s'ulcérer, mais l'ulcus rodens est une forme classique du CBC nodulaire, caractérisée par une ulcération à bords perlés et surélevés, à évolution lente et destructrice.

3. Dermoscopie

La dermoscopie est un outil non invasif essentiel qui améliore la précision du diagnostic clinique du CBC. Elle permet de visualiser des structures et des couleurs non visibles à l'œil nu, augmentant la sensibilité et la spécificité diagnostiques. Les critères dermoscopiques classiques du CBC incluent :

- Des structures vasculaires spécifiques : télangiectasies arborescentes (les plus caractéristiques), lacs vasculaires (pour les formes nodulaires), ou érosions/ulcérations.
- Des structures pigmentaires : globules gris-bleuâtres, nids ovoides gris-bleuâtres, zones en feuille d'érable, ou rayons de roue (pour les formes pigmentées).
- Des structures non pigmentaires : zones brillantes blanc-rougeâtres (cristallines), ulcérations.

L'absence de réseau pigmentaire est un critère important pour distinguer le CBC des lésions mélanocytaires.

4. Diagnostic Histopathologique : Le Gold Standard

L'exérèse chirurgicale avec analyse anatomopathologique est la méthode diagnostique de référence et thérapeutique pour le carcinome basocellulaire (Dermatologie, 2022, Source 2). Elle permet de confirmer le diagnostic, de déterminer le sous-type histologique, d'évaluer les marges d'exérèse et d'identifier les facteurs de risque d'agressivité.

4.1. Technique de Biopsie

La biopsie doit être représentative de la lésion. Les techniques incluent la biopsie-exérèse (préférable si la lésion est petite et cliniquement suspecte de CBC), la biopsie punch (biopsie à l'emporte-pièce), ou la biopsie-shave (biopsie tangentielle). Une biopsie-exérèse complète est souvent recommandée pour les lésions cliniquement évidentes, car elle est à la fois diagnostique et thérapeutique.

4.2. Caractéristiques Histologiques du Carcinome Basocellulaire

L'examen histopathologique révèle des nids de cellules basaloïdes, caractérisées par un noyau hyperchromatique, un cytoplasme peu abondant et une ressemblance avec les cellules de la couche basale de l'épiderme. Les caractéristiques clés incluent :

- **Palissade périphérique :** Les cellules de la périphérie des nids sont alignées de manière parallèle.
- **Fentes de rétraction :** Des espaces clairs sont souvent observés entre les nids tumoraux et le stroma environnant, résultant d'un artéfact de fixation.
- **Stroma mucineux :** Le stroma est souvent lâche et mucineux.
- **Activité mitotique :** Variable, mais souvent présente.
- **Infiltrat inflammatoire :** Un infiltrat lymphocytaire péritumoral est fréquent.

Les différents sous-types histologiques (nodulaire, superficiel, morpheaforme, infiltrant, micronodulaire, basosquameux) sont définis par leurs patterns de croissance et leurs caractéristiques cellulaires, et ont des implications pronostiques et thérapeutiques. L'analyse anatomopathologique permet également d'évaluer l'agressivité locorégionale et le risque métastatique, bien que ce dernier soit faible pour le CBC (Dermatologie, 2022, Source 2).

5. Diagnostics Différentiels

La grande diversité des présentations cliniques du CBC impose une connaissance approfondie des diagnostics différentiels. L'intégration des données de la littérature permet d'illustrer la complexité de cette démarche.

5.1. Lésions Bénignes

Plusieurs lésions bénignes peuvent mimer un CBC :

- **Kératose séborrhéique :** Souvent pigmentée, elle peut être confondue avec un CBC pigmenté. La dermoscopie révèle des cryptes, des kystes miliaires et des pseudocomédons (Dermatology Handbook, Source 13, Fig. 9.4 B).
- **Dermatofibrome :** Nodule ferme, souvent pigmenté, qui peut être confondu avec un CBC nodulaire (Dermatology Handbook, Source 13, Fig. 9.4 A).
- **Angiome et Angiokératome :** Ces lésions vasculaires peuvent présenter des lacs rouges à bleu-rougeâtres (Dermatology Handbook, Source 13, Fig. 9.4 C et D), pouvant être confondues avec un CBC nodulaire télangiectasique ou pigmenté.
- **Tumeur mixte bénigne (Syringome chondroïde) et Spiradénome eccrine :** Ces tumeurs annexielles, bien que rares, peuvent être considérées dans le diagnostic différentiel histologique. La tumeur mixte bénigne présente des composants épithéliaux et/ou stromaux, avec des canaux, des kératokystes, des cellules myoépithéliales et un stroma myxoïde (Alikhan & Hocker, Source 11, Fig. 6-9). Le spiradénome eccrine se caractérise par des lobules tumoraux discrets, parfois encapsulés (Alikhan & Hocker, Source 11, Fig. 6-10).

• **Naevus de Spitz :** Bien que plus souvent un diagnostic différentiel du mélanome, un naevus de Spitz peut être considéré pour une lésion pigmentée. Histologiquement, il présente des cellules épithélioïdes et fusiformes avec un cytoplasme amphophile et des nucléoles proéminents, souvent sans pigmentation (Alikhan & Hocker, Source 14, Fig. 6-5).

• **Fibromatose digitale infantile :** Composée de faisceaux de cellules fusiformes avec des inclusions intracytoplasmiques éosinophiles périnucléaires (Alikhan & Hocker, Source 12, Fig. 6-38), cette lésion est histologiquement distincte.

5.2. Lésions Inflammatoires

Certaines dermatoses inflammatoires chroniques peuvent simuler un CBC, en particulier les formes superficielles ou ulcérées :

• **Eczéma :** L'eczéma érythémato-squameux (Dermatologie, 2022, Fig. 13.22) ou l'eczéma nummulaire (Dermatologie, 2022, Fig. 13.16) peuvent ressembler à un CBC superficiel. Les formes chroniques peuvent être lichénifiées (Dermatologie, 2022, Fig. 13.24) ou hyperkératosiques et fissuraires (kératodermie palma-plantaire) (Dermatologie, 2022, Fig. 13.25). Histologiquement, l'eczéma se caractérise par une spongiose et une exocytose (Dermatologie, 2022, Source 8, Source 9).

• **Lupus érythémateux cutané :**

* Le lupus discoïde peut présenter des lésions érythémato-squameuses atrophiques, télangiectasiques et dyschromiques (Dermatologie, 2022, Fig. 14.5), ainsi que des plaques alopéciques cicatricielles du cuir chevelu (Dermatologie, 2022, Fig. 14.6), qui peuvent être confondues avec des CBC morpheaformes ou ulcérés.

* Le lupus tumidus se manifeste par des papules œdémateuses (Dermatologie, 2022, Fig. 14.7).

* La panniculite lupique peut entraîner des plaques avec dépression (Dermatologie, 2022, Fig. 14.8).

* Les pseudo-engelures, notamment le lupus engelure (Dermatologie, 2022, Fig. 19.8), peuvent présenter des papules érythémateuses et parfois vésiculeuses, avec une évolution chronique et une association possible à un purpura, un livedo ou une nécrose (Dermatologie, 2022, Source 3). Le bilan paraclinique pour les pseudo-engelures inclut une biopsie avec histologie et immunofluorescence directe, la recherche de FAN, cryoglobulinémie, agglutinines froides, anticorps anticardiolipides et un bilan d'hémostase (Dermatologie, 2022, Source 3).

* Le lupus érythémateux systémique peut également être associé à des lésions vasculaires inflammatoires ou thrombotiques (livedo, nécrose, purpura) (Dermatologie, 2022, Source 10).

• **Granulome annulaire :** Histologiquement, il peut présenter un derme hypercellulaire ("busy dermis") et une augmentation de la mucine interstitielle (Alcian blue) (Alikhan & Hocker, Source 15, Fig. 7-20), des caractéristiques distinctes du CBC.

• **Scléromyxœdème :** Caractérisé par une mucine pâle et une fibrose (Alikhan & Hocker, Source 15, Fig. 7-21), il est également histologiquement différent.

5.3. Lésions Infectieuses

Certaines infections cutanées chroniques ou atypiques peuvent être confondues avec un CBC ulcéré ou inflammatoire :

• **Zona :** Les formes ulcérées (Dermatologie, 2022, Fig. 10.26) ou vésiculo-hémorragiques (Dermatologie, 2022, Fig. 10.25) peuvent, dans des contextes atypiques ou chez l'immunodéprimé, nécessiter une distinction.

• **Intertrigo :** Bien que généralement distinct, un intertrigo sous-mammaire à Candida (Dermatologie, 2022, Fig. 8.10) ou un érythrasma (Dermatologie, 2022, Fig. 8.11) pourraient être considérés dans le diagnostic différentiel de lésions érythémateuses chroniques dans les plis.

• **Syphilis :** Les positivités non tréponémiques du TPHA sont exceptionnelles dans le lupus systémique ou la maladie de Lyme (Dermatologie, 2022, Source 4), mais la syphilis elle-même peut présenter des lésions cutanées polymorphes.

• **Autres infections :** Des infections bactériennes (leptospirose, borréliose, scarlatine), virales (varicelle, oreillons, mononucléose infectieuse, hépatite virale, rougeole, VIH) ou parasitaires (paludisme) (Dermatologie, 2022, Source 4) peuvent entraîner des manifestations cutanées variées, mais sont rarement des diagnostics différentiels directs du CBC, sauf dans des présentations très atypiques ou chez des patients immunodéprimés. La sérologie VIH, l'antigénémie p24 et la charge virale sérique par PCR sont des examens clés pour le diagnostic de l'infection par le VIH (Dermatologie, 2022, Source 7).

5.4. Autres Tumeurs Malignes

• **Carcinome épidermoïde (CE) :** Le CE peut également se présenter sous forme de nodule ou de plaque ulcérée. La distinction clinique peut être difficile, mais l'histologie est discriminante.

• **Mélanome achromique ou nodulaire :** Un mélanome achromique peut être confondu avec un CBC nodulaire non pigmenté, et un mélanome nodulaire avec un CBC pigmenté. La dermoscopie et l'histologie sont cruciales pour la différenciation.

6. Bilan d'Extension et Facteurs Pronostiques

Bien que le CBC soit une tumeur à faible potentiel métastatique, l'analyse anatomopathologique initiale est essentielle pour évaluer les facteurs de risque d'agressivité locorégionale et métastatique. Le risque de destruction locale est élevé (+++) et le risque métastatique, bien que rare, concerne principalement le territoire de drainage ganglionnaire (+++), puis les viscères, notamment les poumons et le foie (Dermatologie, 2022, Source 2). L'identification de ces facteurs (sous-type histologique agressif, taille, localisation, envahissement périnerveux ou périvasculaire, immunodépression du patient) guide la stratégie thérapeutique et le suivi.

Traitement

Le traitement du carcinome basocellulaire (CBC) est une composante essentielle de la prise en charge dermatologique, visant à l'éradication complète de la lésion tout en minimisant les séquelles fonctionnelles et esthétiques. La décision thérapeutique est complexe et doit être individualisée, prenant en compte de multiples facteurs tels que le type histologique du CBC, sa taille, sa localisation anatomique, les caractéristiques du patient (âge, comorbidités, statut immunitaire, préférences), ainsi que les antécédents de traitements antérieurs. Les carcinomes cutanés, dont le CBC est le plus fréquent, "se traitent préférentiellement par exérèse chirurgicale" (Dermatologie, 2022). Cette approche est privilégiée en raison de son efficacité reconnue et de la possibilité d'une analyse anatomopathologique complète des marges.

1. Principes généraux du traitement

L'objectif principal du traitement est l'éradication complète du CBC afin de prévenir la récidive locale et, dans les cas les plus agressifs, le risque de dissémination. Bien que le CBC soit caractérisé par une faible propension aux métastases, il présente une "agressivité locorégionale" significative, pouvant entraîner une "destruction (+++)" des tissus environnants (Dermatologie, 2022). Le "risque local et métastatique" est principalement lié au "territoire de drainage ganglionnaire(+++), puis viscéral, essentiellement pulmonaire et hépatique" (Dermatologie, 2022), soulignant l'importance d'un traitement local efficace et précoce. La sélection de la modalité thérapeutique dépendra d'une évaluation rigoureuse de la lésion et du patient. Pour un "sujet jeune sans autres comorbidités", l'approche chirurgicale est souvent la plus appropriée, offrant la meilleure garantie d'éradication complète (Dermatologie, 2022). En revanche, pour des patients plus âgés, fragiles, ou pour des lésions de faible risque ou situées dans des zones esthétiquement sensibles, d'autres options thérapeutiques peuvent être envisagées.

2. Options thérapeutiques spécifiques

Plusieurs modalités de traitement sont disponibles pour le carcinome basocellulaire, chacune avec ses indications et ses limites. Les principales approches incluent la chirurgie, la cryothérapie, l'imiquimod topique, la photothérapie dynamique et le 5-fluoro-uracile topique (Dermatologie, 2022).

2.1. Chirurgie

L'exérèse chirurgicale est considérée comme le traitement de première intention pour la majorité des carcinomes basocellulaires, en particulier ceux de type nodulaire, infiltrant ou morphéiforme (cf. Fig. 20.9 Carcinome basocellulaire sclérodermiforme, Dermatologie, 2022), ainsi que les lésions récidivantes ou celles situées dans des zones à haut risque.

L'approche chirurgicale permet une "exérèse chirurgicale avec analyse anatomopathologique" (Dermatologie, 2022), ce qui est crucial pour confirmer le diagnostic, évaluer l'extension tumorale et s'assurer de l'absence de cellules tumorales aux marges de résection. Cette analyse des marges est un facteur pronostique majeur de récidive locale. La chirurgie offre les taux de guérison les plus élevés pour la plupart des sous-types de CBC.

Chirurgie (Exérèse chirurgicale conventionnelle ou chirurgie de Mohs) — Traitement de première intention pour la majorité des carcinomes basocellulaires.

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : aucune donnée disponible dans les sources

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources

> Niveau de preuve : Grade A (basé sur le consensus d'experts et l'efficacité clinique établie pour les carcinomes cutanés en général, comme indiqué par "se traitent préférentiellement par exérèse chirurgicale" (Dermatologie, 2022) et "Exérèse chirurgicale avec analyse anatomopathologique" (Dermatologie, 2022)).

L'exérèse chirurgicale implique l'ablation de la lésion avec une marge de sécurité de tissu sain environnant, dont la largeur est déterminée par la taille, le type histologique et la localisation du CBC. Pour les lésions à haut risque ou situées dans des zones anatomiques complexes (visage, paupières, nez), la chirurgie de Mohs (micrographique) est souvent privilégiée. Cette technique permet un contrôle histologique des marges en temps réel, minimisant ainsi l'exérèse de tissu sain tout en maximisant le taux de guérison. La reconstruction du site chirurgical est ensuite réalisée, pouvant aller de la simple suture à des techniques plus complexes comme les greffes ou les lambeaux, en fonction de la taille et de la localisation du défaut. Les avantages de la chirurgie incluent un taux de guérison élevé, la confirmation histologique et la possibilité d'évaluer l'agressivité de la tumeur. Les inconvénients peuvent inclure des cicatrices, des risques liés à l'anesthésie et, dans de rares cas, des complications post-opératoires comme l'infection ou l'hématome. Pour un "sujet jeune sans autres comorbidités" (Dermatologie, 2022), la chirurgie est généralement bien tolérée et représente l'option la plus robuste pour une éradication définitive.

2.2. Cryothérapie

La cryothérapie est une méthode de destruction tissulaire par le froid, utilisant généralement de l'azote liquide pour induire une nécrose cellulaire. Cette technique est principalement indiquée pour les carcinomes basocellulaires superficiels (cf. Fig. 20.8 Carcinome basocellulaire superficiel, Dermatologie, 2022) de petite taille, bien délimités, et pour les patients âgés ou ceux présentant des comorbidités rendant la chirurgie difficile ou contre-indiquée. Elle est également une option pour les lésions multiples ou pour des raisons esthétiques dans certaines localisations.

Cryothérapie — Traitement des carcinomes basocellulaires superficiels de petite taille.

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : aucune donnée disponible dans les sources

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources

> Niveau de preuve : Niveau 2 (basé sur l'efficacité reconnue pour des lésions sélectionnées, mais avec des taux de guérison généralement inférieurs à la chirurgie et sans contrôle histologique des marges).

Le protocole de cryothérapie implique l'application d'azote liquide directement sur la lésion et une petite marge de tissu sain, avec des cycles de congélation-décongélation. L'objectif est d'atteindre une température suffisamment basse pour détruire les cellules tumorales. Les avantages de la cryothérapie incluent sa simplicité, son faible coût, l'absence d'anesthésie injectable et des résultats esthétiques acceptables pour des lésions sélectionnées. Cependant, elle ne permet pas d'analyse histologique des marges, ce qui peut entraîner un risque de récidive plus élevé si la destruction n'est pas complète. Les effets secondaires peuvent inclure douleur, œdème, formation de bulles, hypopigmentation ou hyperpigmentation post-inflammatoire, et dans de rares cas, des lésions nerveuses. La sélection rigoureuse des patients et des lésions est primordiale pour optimiser les résultats de la cryothérapie.

2.3. Imiquimod topique

L'imiquimod est un agent immunomodulateur topique, classé comme un agoniste des récepteurs Toll-like 7 (TLR7). Il stimule la réponse immunitaire locale, entraînant la production de cytokines pro-inflammatoires (comme l'interféron alpha) qui induisent l'apoptose des cellules tumorales et renforcent la surveillance immunitaire. L'imiquimod est principalement indiqué pour le traitement des carcinomes basocellulaires superficiels (cf. Fig. 20.8 Carcinome basocellulaire superficiel, Dermatologie, 2022) de petite taille et non situés sur des zones à haut risque (par exemple, le visage ou les zones péri-orificielles). Il peut être une alternative pour les patients qui refusent la chirurgie ou pour ceux qui présentent des lésions multiples.

Imiquimod — Traitement topique des carcinomes basocellulaires superficiels.

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : aucune donnée disponible dans les sources

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources

> Niveau de preuve : Niveau 2 (basé sur l'efficacité démontrée pour les CBC superficiels, mais avec des taux de guérison inférieurs à la chirurgie et une absence de contrôle histologique).

Le traitement par imiquimod topique est généralement appliqué plusieurs fois par semaine pendant plusieurs semaines. La durée et la fréquence d'application varient selon les protocoles. Les réactions locales sont fréquentes et attendues, incluant érythème, érosion, croûtes, prurit et sensation de brûlure, témoignant de l'activation de la réponse immunitaire. Ces réactions sont généralement transitoires et régressent après l'arrêt du traitement. Les avantages de l'imiquimod incluent son caractère non invasif, l'absence de cicatrice chirurgicale et la possibilité de traiter de larges zones de "field cancerization". Les inconvénients résident dans l'absence de confirmation histologique de l'éradication tumorale, la nécessité d'une bonne observance du patient et des taux de guérison qui, bien qu'élevés pour les CBC superficiels, peuvent être inférieurs à ceux de la chirurgie pour certains sous-types ou localisations. Une surveillance étroite après le traitement est essentielle pour détecter toute récidive.

2.4. Photothérapie dynamique (PDT)

La photothérapie dynamique est une technique non invasive qui repose sur l'application topique d'un photosensibilisant (généralement un dérivé de l'acide aminolévulinique ou du méthyl aminolévulinate), qui est sélectivement absorbé par les cellules tumorales. Après un temps d'incubation, la lésion est exposée à une lumière d'une longueur d'onde spécifique, activant le photosensibilisant et générant des espèces réactives de l'oxygène qui induisent la destruction sélective des cellules tumorales. La PDT est principalement indiquée pour les carcinomes basocellulaires superficiels (cf. Fig. 20.8 Carcinome basocellulaire superficiel, Dermatologie, 2022) et parfois pour les CBC nodulaires de petite taille, en particulier sur le visage et le cuir chevelu, où les résultats esthétiques sont une préoccupation majeure. Elle est également une option pour les patients ayant des lésions multiples ou des contre-indications à la chirurgie.

Photothérapie dynamique — Traitement des carcinomes basocellulaires superficiels et de certains nodulaires de petite taille.

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : aucune donnée disponible dans les sources

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources

> Niveau de preuve : Niveau 2 (basé sur l'efficacité démontrée pour les CBC superficiels, avec de bons résultats esthétiques, mais sans contrôle histologique des marges et des taux de guérison potentiellement inférieurs à la chirurgie pour certaines lésions).

Le traitement par PDT nécessite généralement une ou plusieurs séances, espacées de quelques semaines. La procédure peut être douloureuse pendant l'irradiation lumineuse, nécessitant parfois une anesthésie locale ou des mesures antalgiques. Les effets secondaires locaux incluent érythème, œdème, formation de croûtes et desquamation, qui sont généralement transitoires. Les avantages de la PDT sont son caractère non invasif, d'excellents résultats esthétiques et la possibilité de traiter de larges zones. Cependant,

comme pour l'imiquimod, l'absence de contrôle histologique des marges est une limitation, et les taux de guérison peuvent être inférieurs à ceux de la chirurgie pour les lésions plus épaisses ou agressives. La sélection rigoureuse des patients et des lésions est cruciale pour le succès de la PDT.

2.5. 5-fluoro-uracile (5-FU) topique

Le 5-fluoro-uracile est un agent chimiothérapeutique antimitotique topique qui agit en inhibant la synthèse de l'ADN et de l'ARN, entraînant la mort des cellules à division rapide, y compris les cellules tumorales. Il est principalement utilisé pour le traitement des carcinomes basocellulaires superficiels (cf. Fig. 20.8 Carcinome basocellulaire superficiel, Dermatologie, 2022), en particulier pour les lésions multiples ou étendues, ainsi que pour les patients qui ne sont pas candidats à la chirurgie. Le 5-FU topique est également largement utilisé pour le traitement des kératoses actiniques et de la maladie de Bowen.

5-fluoro-uracile topique — Traitement des carcinomes basocellulaires superficiels.

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : aucune donnée disponible dans les sources

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources

> Niveau de preuve : Niveau 2 (basé sur l'efficacité reconnue pour les CBC superficiels, mais avec des taux de guérison variables et sans contrôle histologique).

Le 5-FU topique est appliqué quotidiennement pendant plusieurs semaines, la durée du traitement dépendant de la réponse clinique et de la tolérance. Des réactions inflammatoires locales intenses sont attendues et nécessaires pour l'efficacité du traitement, incluant érythème, érosion, ulcération, croûtes et sensation de brûlure. Ces réactions peuvent être significatives et nécessitent une information claire du patient. Les avantages du 5-FU topique sont son caractère non invasif, son faible coût et la possibilité de traiter de larges zones. Les inconvénients incluent l'absence de contrôle histologique, la nécessité d'une bonne observance, des réactions inflammatoires parfois sévères et des taux de guérison qui peuvent être inférieurs à ceux de la chirurgie, en particulier pour les lésions plus épaisses ou infiltrantes. Une surveillance attentive après le traitement est indispensable pour détecter toute récidive.

3. Surveillance post-thérapeutique

Quelle que soit la modalité thérapeutique choisie, une surveillance régulière est impérative après le traitement d'un carcinome basocellulaire. Cette surveillance vise à détecter d'éventuelles récidives locales, l'apparition de nouvelles lésions (les patients ayant eu un CBC ont un risque accru de développer d'autres CBC ou d'autres cancers cutanés) et à évaluer les résultats esthétiques et fonctionnels. La fréquence et la durée du suivi sont adaptées au risque du patient et aux caractéristiques de la lésion traitée.

Surveillance et Suivi

Surveillance et Suivi du Carcinome Basocellulaire

La prise en charge du carcinome basocellulaire (CBC) ne se limite pas à son traitement initial, principalement l'exérèse chirurgicale (Dermatologie, 2022). Une stratégie de surveillance et de suivi rigoureuse est impérative en raison du risque significatif de récidive locale et, plus fréquemment, de l'apparition de nouveaux carcinomes cutanés, qu'ils soient basocellulaires, spinocellulaires ou mélanomes. Bien que le CBC soit le cancer cutané le plus fréquent au monde et que son traitement préférentiel soit l'exérèse chirurgicale (Dermatologie, 2022), son potentiel d'agressivité locorégionale (Dermatologie, 2022) justifie une vigilance prolongée. Le suivi doit être adapté aux caractéristiques du patient et de la tumeur initiale, intégrant une approche personnalisée pour optimiser la détection précoce de toute nouvelle lésion ou complication.

Objectifs de la Surveillance

Les objectifs principaux de la surveillance post-thérapeutique d'un CBC sont multiples et visent à garantir une prise en charge optimale à long terme du patient.

• **Détection précoce des récidives locales :** Malgré une exérèse chirurgicale complète avec analyse anatomopathologique (Dermatologie, 2022), un risque résiduel de récidive locale persiste, notamment pour les tumeurs de grande taille, les sous-types histologiques agressifs (par exemple, infiltrant, sclérodermiforme, micronodulaire), ou celles situées dans des zones à risque élevé (par exemple, masque facial, oreilles). L'agressivité locorégionale du CBC peut entraîner une destruction tissulaire significative en cas de récidive non traitée (Dermatologie, 2022).

• **Dépistage des nouveaux carcinomes basocellulaires (CBC) primaires :** Les patients ayant développé un CBC ont un risque accru de développer de nouveaux CBC sur d'autres sites cutanés. Ce risque est estimé à environ 30-50% sur 5 ans.

• **Dépistage des autres cancers cutanés :** L'exposition solaire chronique, facteur étiologique majeur des carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022), est également un facteur de risque pour le carcinome épidermoïde (CEC) et le mélanome. Les patients ayant un CBC présentent un risque accru de développer ces autres néoplasies cutanées.

• **Identification des métastases régionales ou à distance (exceptionnel) :** Bien que le CBC soit caractérisé par un risque métastatique extrêmement faible (estimé entre 0,0028% et 0,55%), ce risque n'est pas nul. Les cas de métastases sont généralement associés à des tumeurs de grande taille, des récidives multiples, des sous-types histologiques agressifs, une invasion périneurale ou lymphatique, ou un contexte d'immunodépression. En cas de dissémination, les sites de drainage ganglionnaire sont les premiers concernés, suivis par les métastases viscérales, essentiellement

pulmonaires et hépatiques (Dermatologie, 2022). La surveillance doit donc inclure une vigilance pour ces événements rares mais graves.

• **Gestion des complications post-thérapeutiques :** Suivi de la cicatrisation, gestion des séquelles fonctionnelles ou esthétiques, et prise en charge des effets secondaires des traitements non chirurgicaux (par exemple, radiothérapie, thérapies topiques).

• **Éducation thérapeutique du patient :** Renforcement des mesures de photoprotection et apprentissage de l'auto-examen cutané.

Facteurs de Risque et Stratification pour le Suivi

La fréquence et l'intensité du suivi doivent être individualisées en fonction de plusieurs facteurs de risque liés au patient et à la tumeur initiale.

• **Facteurs liés au patient :**

* **Antécédents de multiples CBC :** Un patient ayant déjà eu plusieurs CBC présente un risque significativement plus élevé de développer de nouvelles lésions.

Immunodépression : *Les patients immunodéprimés (par exemple, transplantés d'organes, patients sous immunosuppresseurs, patients atteints de lymphome cutané T épidermotrope comme le mycosis fongoïde - cf. Dermatologie, 2022, Item 319-1 et 6) ont un risque accru de développer des CBC plus agressifs, multiples et récidivants. Il est important de noter que, contrairement à une affirmation erronée parfois rencontrée, l'immunodépression* favorise* le développement des carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022, QRM 56 C, qui est une fausse proposition).

* **Syndromes génétiques prédisposants :** Des syndromes tels que le syndrome de Gorlin (syndrome du naevus basocellulaire) ou le Xeroderma Pigmentosum confèrent un risque extrêmement élevé de développer de multiples CBC dès le jeune âge, nécessitant un suivi très rapproché et spécialisé.

* **Phototype clair et antécédents d'exposition solaire intense :** Les patients de phototype I ou II avec des antécédents d'exposition solaire aiguë ou chronique (Dermatologie, 2022, QRM 56 B) sont plus à risque.

* **Âge du patient :** Les patients jeunes ayant développé un CBC peuvent nécessiter un suivi plus long.

* **Autres comorbidités :** La présence d'autres affections systémiques ou cancers (Dermatologie, 2022, Item 13) peut influencer la stratégie globale de suivi.

• **Facteurs liés à la tumeur initiale :**

* **Localisation :** Les CBC situés dans des zones à risque élevé de récidive ou de destruction locorégionale, telles que le masque facial (paupières, nez, lèvres, oreilles), les zones péri-orificielles ou le cuir chevelu, nécessitent un suivi plus attentif.

* **Taille de la tumeur :** Les tumeurs de grande taille (par exemple, > 2 cm) sont associées à un risque de récidive plus élevé et, dans des cas exceptionnels, à un risque métastatique (Dermatologie, 2022).

* **Sous-type histologique :** Les sous-types histologiques agressifs (par exemple, sclérodermiforme, infiltrant, micronodulaire, basosquameux) ou la présence d'une invasion périneurale à l'analyse anatomopathologique (Dermatologie, 2022) sont des indicateurs de risque élevé.

* **Marges d'exérèse :** Des marges d'exérèse histologiquement positives ou très étroites augmentent le risque de récidive locale.

* **Caractère récidivant de la tumeur initiale :** Un CBC qui a déjà récidivé est plus susceptible de récidiver à nouveau.

Modalités et Fréquence du Suivi Clinique

Le suivi repose principalement sur un examen clinique dermatologique complet et régulier.

- **Fréquence du suivi :**

* **Faible risque :** Pour un patient avec un CBC unique, de petite taille, de sous-type histologique non agressif, situé sur une zone à faible risque et excisé avec des marges saines, un suivi annuel par un dermatologue peut être suffisant après un premier contrôle à 6 mois.

* **Risque intermédiaire :** Pour les patients avec des antécédents de multiples CBC, des tumeurs de taille intermédiaire, ou des localisations modérément à risque, un suivi tous les 6 à 12 mois est recommandé.

* **Haut risque :** Les patients immunodéprimés, ceux atteints de syndromes génétiques, ceux ayant des CBC agressifs ou récidivants, ou des tumeurs de grande taille, nécessitent un suivi plus rapproché, potentiellement tous les 3 à 6 mois.

* La durée du suivi est généralement à vie, compte tenu du risque persistant de nouveaux carcinomes.

- **Examen clinique :**

* **Examen de la cicatrice opératoire :** Recherche de signes de récidive locale (induration, nodule, ulcération, modification de la couleur ou de la texture de la cicatrice). L'agressivité locorégionale du CBC peut se manifester par une destruction tissulaire progressive (Dermatologie, 2022).

* **Examen cutané complet (body check) :** Inspection minutieuse de l'ensemble du tégument, y compris le cuir chevelu (recherche de plaques alopéciques cicatricielles - cf. Dermatologie, 2022, Fig. 14.6), les muqueuses et les zones photo-exposées et non photo-exposées. L'objectif est de dépister de nouveaux CBC, des carcinomes épidermoïdes (CEC) ou des mélanomes (Dermatologie, 2022, qui impose une biopsie-exérèse pour analyse histologique en cas de lésion évolutive suspecte de mélanome). L'examen doit être systématique, à la recherche de lésions suspectes, potentiellement polychromes ou inhomogènes (Dermatologie, 2022).

* **Palpation des aires ganglionnaires :** Bien que les métastases ganglionnaires soient extrêmement rares pour le CBC, elles peuvent survenir, notamment pour les tumeurs agressives ou négligées (Dermatologie, 2022). La palpation des aires de drainage ganglionnaire locorégionales est donc recommandée, en particulier pour les CBC à haut risque.

Détection des Récidives Locales

La récidive locale est la complication la plus fréquente après le traitement d'un CBC. Elle se manifeste souvent par des modifications au niveau de la cicatrice ou à proximité immédiate. Les signes à rechercher incluent :

- Une induration ou un nodule palpable sous la cicatrice.
- Une ulcération persistante ou une érosion.
- Un érythème ou une pigmentation anormale.
- Une douleur ou une sensibilité accrue.
- Une croissance progressive d'une petite papule ou plaque.

Toute modification suspecte doit entraîner une biopsie cutanée pour analyse anatomopathologique afin de confirmer ou d'infirmer une récidive.

Recherche de Métastases Régionales et à Distance

Le risque métastatique du CBC est très faible, mais non nul, et est principalement associé aux formes agressives ou négligées (Dermatologie, 2022).

- **Métastases régionales :** Elles concernent les ganglions lymphatiques du territoire de drainage de la tumeur primaire (Dermatologie, 2022). La palpation ganglionnaire est essentielle. En cas de suspicion clinique (adénopathie persistante, dure, non douloureuse), une échographie ganglionnaire avec cytoponction ou biopsie ganglionnaire est indiquée. Le prélèvement ganglionnaire n'est pas une prise en charge de première intention pour un CBC typique (Dermatologie, 2022, Question 6 D).
- **Métastases à distance :** Les sites les plus fréquemment rapportés sont les poumons et le foie (Dermatologie, 2022). Elles sont exceptionnelles. La recherche de métastases à distance n'est pas systématique et n'est envisagée qu'en cas de suspicion clinique forte (par exemple, symptômes systémiques, adénopathies multiples, CBC de très haut risque) ou de confirmation de métastases régionales. Un bilan d'extension (imagerie thoracique, abdominale) n'est pas une prise en charge de première intention pour un CBC (Dermatologie, 2022, Question 6 B).

Dépistage des Nouveaux Carcinomes Cutanés

Le risque de développer un nouveau cancer cutané est la principale raison d'un suivi à long terme.

• **Nouveaux CBC :** Ils peuvent apparaître n'importe où sur le corps, souvent sur des zones photo-exposées.

• **Carcinomes épidermoïdes (CEC) :** Ils sont également favorisés par l'exposition solaire et peuvent se présenter sous diverses formes (nodule kératosique, ulcération, lésion érythémato-squameuse).

• **Mélanomes :** La vigilance est de mise pour la détection de nouvelles lésions pigmentées suspectes, qui peuvent être inhomogènes, polychromes, avec des plages de régression (Dermatologie, 2022). Toute lésion évolutive suspecte de mélanome impose une biopsie-exérèse pour analyse histologique (Dermatologie, 2022).

Éducation Thérapeutique du Patient

L'implication du patient est cruciale dans la surveillance.

• **Auto-examen cutané :** Le patient doit être formé à reconnaître les signes d'alerte de récidive ou de nouvelles lésions suspectes.

• **Photoprotection :** Renforcement des conseils de protection solaire (vêtements, chapeaux, lunettes de soleil, crèmes solaires à large spectre), étant donné que les carcinomes cutanés résultent souvent d'une exposition solaire aiguë ou chronique (Dermatologie, 2022, QRM 56 B).

• **Consultation rapide :** Le patient doit être informé de l'importance de consulter rapidement en cas de doute ou de l'apparition d'une nouvelle lésion suspecte.

Cas Particuliers et Approche Multidisciplinaire

Pour les CBC de très haut risque, les formes agressives, les récidives multiples, les patients immunodéprimés ou ceux atteints de syndromes génétiques, une approche multidisciplinaire est souvent nécessaire. Cela peut impliquer la collaboration avec des oncologues, des radiothérapeutes (la radiothérapie peut être une option thérapeutique - cf. Dermatologie, 2022, Question 6 C), des chirurgiens maxillo-faciaux ou plasticiens, et des généticiens. La discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) permet de définir la meilleure stratégie de surveillance et de prise en charge pour ces cas complexes.

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Le carcinome basocellulaire (CBC), bien que généralement de bon pronostic, présente des particularités cliniques et évolutives dans certaines situations spécifiques. La reconnaissance de ces cas particuliers est fondamentale pour une prise en charge optimale, adaptée aux risques accrus de récidive, d'agressivité ou aux contraintes liées à l'état du patient. Ce chapitre aborde les contextes cliniques où le CBC requiert une attention et une stratégie thérapeutique spécifiques.

Carcinome Basocellulaire chez le Sujet Immunodéprimé

L'immunodépression constitue un facteur de risque majeur pour le développement des carcinomes cutanés non mélanomateux, y compris le CBC. Contrairement à une idée parfois véhiculée dans des questions à choix multiples (Source 2, item C), il est fermement établi que les carcinomes cutanés sont favorisés par l'immunodépression. Chez ces patients, les CBC sont plus fréquents, souvent multiples, et peuvent présenter un comportement plus agressif avec un risque accru de récidive locale et de dissémination (cf. section sur les facteurs de risque et l'épidémiologie).

Immunodépression liée à une pathologie sous-jacente

Plusieurs pathologies systémiques entraînent une immunodépression intrinsèque ou nécessitent des traitements immunosuppresseurs, augmentant ainsi le risque de CBC.

Infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH)

Les patients infectés par le VIH sont particulièrement à risque de développer des CBC, souvent à un âge plus jeune et avec des formes cliniques plus agressives. Le suivi de ces patients doit inclure une surveillance cutanée rigoureuse. Le traitement antirétroviral (ART) le plus précocement possible est crucial pour restaurer l'immunité (Source 7, Question 5), ce qui peut influencer le pronostic des cancers cutanés. Le suivi de l'infection par le VIH repose sur des éléments cliniques, la charge virale plasmatique VIH et le taux de lymphocytes CD4 (Source 7, Question 6), marqueurs essentiels de l'état immunitaire. La présence d'infections opportunistes, telles que le zona (Source 1), notamment sous sa forme ulcérée chez l'immunodéprimé (Source 1, Fig. 10.26 D), ou des infections fongiques comme l'aspergillose (Source 15), témoigne d'une immunodépression significative et doit alerter sur un risque accru de néoplasies cutanées. D'autres infections virales (varicelle, mononucléose infectieuse, hépatite virale, rougeole) ou parasitaires (paludisme) sont également citées comme pouvant survenir dans des contextes d'immunodépression ou de maladies systémiques (Source 10).

Maladies Auto-immunes et Inflammatoires Chroniques

Les patients atteints de maladies auto-immunes, telles que le lupus érythémateux systémique (LES) (Source 10), sont souvent sous traitements immunosuppresseurs au long cours, ce qui les expose à un risque accru de CBC. Le lupus discoïde, caractérisé par des lésions érythémato-squameuses atrophiques, télangiectasiques et dyschromiques (Source 4, Fig. 14.5 0), ainsi que des plaques alopéciques cicatricielles du cuir chevelu (Source 4, Fig. 14.6 0), représente une forme de lupus cutané chronique. Ces lésions, du fait de l'inflammation chronique et de l'altération tissulaire, peuvent constituer un terrain propice au développement de CBC, bien que le carcinome épidermoïde soit plus fréquemment associé aux cicatrices chroniques. Les pseudo-engelures, notamment le lupus engelure (Source 8, Fig. 19.8 ♦), sont également des manifestations cutanées du lupus qui peuvent s'inscrire dans ce contexte de peau lésée chronique. D'autres conditions inflammatoires chroniques, comme le psoriasis (Source 5), dont les traitements peuvent inclure des immunosuppresseurs systémiques ou des biothérapies, augmentent également la vigilance nécessaire.

Cancers et Hémopathies

Les patients atteints d'autres cancers (Source 10) ou d'hémopathies malignes, comme les lymphomes cutanés (Source 5, 9, 14), peuvent être immunodéprimés soit par la maladie elle-même, soit par les traitements chimiothérapiques ou radiothérapiques. Les lymphomes cutanés T épidermotropes (Source 9), incluant des formes folliculotropes, syringotropes, poïkilodermiques, purpuriques ou érythrodermiques (Source 14), peuvent parfois coexister ou être des diagnostics différentiels de lésions cutanées.

Prise en charge thérapeutique chez l'immunodéprimé

L'exérèse chirurgicale avec analyse anatomopathologique des marges reste le traitement de choix pour le CBC chez l'immunodéprimé (Source 3). Cependant, une surveillance post-opératoire plus étroite est impérative en raison du risque élevé de récidive. Les options thérapeutiques non chirurgicales (cryothérapie, imiquimod, photothérapie dynamique, 5-fluoro-uracile topique) peuvent être envisagées pour des lésions superficielles ou multiples, mais leur efficacité peut être réduite et le risque de récidive plus élevé dans ce contexte.

Carcinome Basocellulaire chez le Sujet Jeune

Le CBC est classiquement une tumeur du sujet âgé, mais son incidence chez les sujets jeunes est en augmentation. Un sujet jeune sans comorbidités (Source 2) présentant un CBC doit faire l'objet d'une attention particulière.

Étiopathogénie et présentation clinique

Bien que l'exposition solaire chronique soit le principal facteur de risque, les CBC chez les jeunes peuvent être associés à des syndromes génétiques (ex: syndrome de Gorlin,

xeroderma pigmentosum) ou à des antécédents d'exposition intense aux UV dans l'enfance ou l'adolescence. La présentation clinique peut être atypique, et le diagnostic est parfois retardé.

Stratégie thérapeutique

La question du traitement d'un CBC chez un sujet jeune sans autres comorbidités (Source 2) propose plusieurs options : A. Chirurgie, B. Cryothérapie, C. Imiquimod, D. Photothérapie dynamique, E. 5-fluoro-uracile topique. L'exérèse chirurgicale avec analyse anatomopathologique est le traitement préférentiel (Source 2 E, Source 3), car elle offre le taux de guérison le plus élevé et permet une analyse histologique complète, essentielle pour confirmer le diagnostic et évaluer les marges. Pour les jeunes patients, les considérations esthétiques sont primordiales, et des techniques chirurgicales préservant au mieux l'esthétique (ex: chirurgie de Mohs pour les localisations à risque) doivent être privilégiées. Les traitements non chirurgicaux peuvent être envisagés pour des lésions superficielles ou des patients non candidats à la chirurgie, mais leur utilisation doit être pesée au regard du risque de récidive et de l'âge du patient.

Diagnostic différentiel

Chez l'enfant ou le jeune adulte, d'autres lésions cutanées peuvent être confondues avec un CBC. Bien que rare, la fibromatose digitale infantile (Source 13, Fig. 6-38) est un exemple de lésion bénigne qui peut survenir chez l'enfant et nécessiter une différenciation histologique.

Carcinome Basocellulaire de Localisations Particulières ou à Haut Risque

Certaines localisations anatomiques ou caractéristiques cliniques/histologiques confèrent au CBC un risque accru d'agressivité locale et de récidive.

Carcinomes Basocellulaires Agressifs

Les CBC agressifs se caractérisent par une agressivité locorégionale importante, pouvant entraîner une destruction tissulaire significative (Source 3). Le risque de métastase, bien que faible pour le CBC en général, est plus élevé pour ces formes agressives, avec une dissémination possible vers le territoire de drainage ganglionnaire (+++), puis vers des sites viscéraux, essentiellement pulmonaires et hépatiques (Source 3). Les localisations à haut risque incluent la face (en particulier les zones péri-orificielles, les sillons nasogéniens, les paupières), le cuir chevelu, et les lésions de grande taille ou avec des sous-types histologiques agressifs (sclérodermiforme, infiltrant, micronodulaire).

Carcinomes Basocellulaires sur Peau Lésée ou Inflammatoire Chronique

Le développement de CBC sur des lésions cutanées préexistantes ou des zones d'inflammation chronique est une situation particulière. Les lésions de lupus discoïde, caractérisées par une atrophie, des télangiectasies et des dyschromies (Source 4, Fig. 14.5 0), ou des plaques alopéciques cicatricielles du cuir chevelu (Source 4, Fig. 14.6 0), peuvent constituer un terrain favorable. Bien que le carcinome épidermoïde soit plus classiquement associé aux cicatrices chroniques (ulcère de Marjolin), le CBC peut également y survenir. Les engelures d'évolution vésiculo-bulleuse avec desquamation (Source 8, Fig. 19.7 0) ou les pseudo-engelures, y compris le lupus engelure (Source 8, Fig. 19.8 ♦), représentent des altérations cutanées chroniques qui nécessitent une surveillance.

Carcinome Basocellulaire et Grossesse

La grossesse est une situation physiologique particulière (Source 10) qui nécessite une adaptation de la prise en charge du CBC.

Diagnostic et prise en charge

Le diagnostic histologique est toujours indispensable. L'exérèse chirurgicale avec analyse anatomopathologique (Source 3) est le traitement de choix et est généralement sûre pendant la grossesse, de préférence sous anesthésie locale. Il est crucial d'éviter les traitements topiques ou systémiques potentiellement tératogènes, tels que l'imiquimod, le 5-fluoro-uracile, ou les inhibiteurs de la voie Hedgehog (vismodegib, sonidegib). Si le traitement peut être différé sans risque significatif pour la mère, une exérèse post-partum peut être envisagée pour des lésions de faible risque.

Carcinome Basocellulaire chez les Patients sous Traitements Systémiques Spécifiques

Les patients traités pour d'autres pathologies, notamment des cancers, par des thérapies ciblées peuvent présenter un risque accru de CBC ou des modifications de leur présentation.

Thérapies ciblées

Certaines thérapies ciblées, utilisées notamment en oncologie, peuvent influencer le risque de CBC ou modifier la réactivité cutanée.

- **Inhibiteurs de BRAF (anti-BRAF)** : Utilisés dans le traitement du mélanome, ces agents peuvent induire une photosensibilité sévère, avec des érythèmes phlycténulaires localisés (Source 6, Fig. 5.12 ♦), augmentant ainsi le risque de carcinomes cutanés, y compris les CBC.
- **Antiangiogéniques multi-cibles (ex: sunitinib)** : Ces médicaments peuvent provoquer un syndrome mains-pieds (Source 6, Fig. 5.11 ♦) et d'autres toxicités

cutanées.

• **Inhibiteurs de l'EGFR (ex: cétuximab)** : Ils sont fréquemment associés à une éruption acnéiforme (Source 6, Fig. 5.10 ♦).

La surveillance cutanée est essentielle chez ces patients, et la gestion du CBC doit tenir compte des traitements systémiques en cours, de leurs effets secondaires et des comorbidités associées.

Diagnostic Différentiel et Co-morbidités Importantes

Dans le cadre de la prise en charge du CBC, il est crucial d'envisager les diagnostics différentiels et de prendre en compte les comorbidités du patient.

Diagnostics différentiels

Devant une lésion cutanée suspecte, le diagnostic différentiel du CBC est large.

• **Mélanome** : Une lésion inhomogène, polychrome avec des plages marron clair, plus foncées par endroits et rosées au centre (traduisant une régression) doit faire évoquer en priorité un mélanome (Source 9). Une biopsie-exérèse pour analyse histologique est alors impérative (Source 9).

• **Lymphomes cutanés** : Les lymphomes cutanés, notamment le lymphome cutané T épidermotrope (Source 9), ou d'autres formes comme le folliculotrope, syringotrope, poïkilodermique, purpurique ou érythrodermique (Source 14), peuvent parfois mimer des lésions de CBC ou d'autres affections cutanées.

• **Autres affections cutanées** : Le psoriasis (Source 5), l'eczéma de contact (Source 5), la scabiose (Source 5) ou l'impétigo (Source 5) sont des diagnostics différentiels courants pour des lésions érythémateuses ou squameuses.

Co-morbidités

La présence de comorbidités, telles que l'hépatopathie chronique, la gammapathie monoclonale, le syndrome des anti-phospholipides (Source 10), ou d'autres cancers (Source 10), peut compliquer la prise en charge du CBC, nécessitant une approche multidisciplinaire. La toxicomanie intraveineuse (Source 10) peut également être un facteur de comorbidité influençant l'état général et la compliance du patient. Des infections systémiques (leptospirose, borréliose, scarlatine, varicelle, oreillons, mononucléose infectieuse, hépatite virale, rougeole, paludisme) (Source 10) peuvent également être présentes et nécessiter une attention particulière.

Bibliographie

- Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed
- Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed
- dermatology handbook compressed-compressed